جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح احمد احمد محمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اخري **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 26212192100742 **رقم التليفون :** 01120712969 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 19-12-1962 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صباح احمد احمد محمد
National ID: 26212192100742

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Supportive and palliative Treatment**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name: sabah ahmed ahmed

Date : 21-09-2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

A known case of left breast cancer.

1. *Chest:*
   - Left breast large heterogeneously enhanced skin infiltrating mass is seen measuring about 10x7 cm.
   - Left axillary level I and II enlarged lymph nodes are seen the largest measures about 24x15 mm.
   - Bilateral pulmonary few tiny scattered nodules the largest is seen at the left lower lung superior segment measuring about 6 mm.
   - Right lower and middle lung lobes and left lingular atelectatic bands are seen.
   - No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
   - Few thyroid small hypodense nodules are seen.

2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic masses or collections.
   - Diverticular disease of the sigmoid is seen.
   - Bulky uterus with fundal mass and downward displacement of IUCD.
   - Skeletal examination revealed:
     - Dorsolumbar spondyiotic changes.
     - Bilateral scaroiliitis.
     - Sternal and left iliac sclerotic bone lesions likely bone islands.
     - Otherwise, no lytic or sclerotic bone lesions.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name: صباح احمد احمد محمد **MR. :** 5006	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented today for a Zometa infusion only; laboratory studies performed externally were accepted with a serum creatinine of 0.9 mg/dL, ionized calcium of 1.19 mmol/L, and total calcium of 9.64 mg/dL.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

OPINION:

- Left breast large heterogeneously enhanced skin infiltrating mass with left axillary enlarged lymph nodes.
- Bilateral pulmonary few tiny scattered nodules likely of benign nature for follow up.

Dr. Reham Anwar, MSc, FEBR

Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

18-10-2021

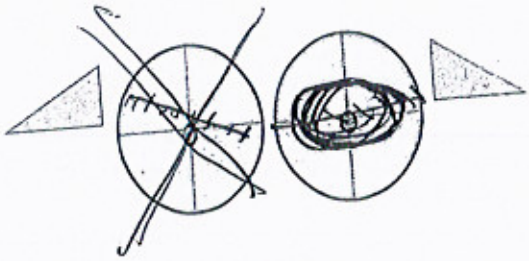
مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

البنت المصرية هي صحة مصر

MDT FORM

left Br. Ca

Name	[illegible]
Age	58
MRN	٤٦٢١٢١٩٤١٠٠٧٤٤
ID	3601 / 2021
Co morbidity	٠١١١١١٧٠٧٠٦



Clinical Data

Bx: Invasive mucinous carcinoma	SM: left breast malignant lesion with pathological ipsilateral axillary lymphnodes
IHC: ER: 8/8 PR: 6/8 Her٢: 0 Ki٦٧: 5-10%	Mets Workup: Bilateral pulmonary few tiny scattered nodules likely of benign nature
cT4bN0M0 nipple infiltrated	
COMMENT:	

MDT OUTCOME & PLAN

Neoadj Chem AC x4 → Taxotere x4

→ MRM.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / صباح احمد احمد محمد	Request No.	: 135577
Patient No.	: 26212192100742	Request Date	: 21/09/2021
Path No.	: 2180	Verification Date	: 10/10/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referreing Docto:		IHC No.	:

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Lt breast mass

Nature of the speciment:
tru cut biopsy
Gross Examination:
• multiple fragmented gray white tissue cores up to 1x1 cm long, totally submitted

Microscopic examination:
• Histological type: IDC (mucinous carcinoma)
• Grade II
• Angioinvasion: NO
• Ductal carcinoma in situ: NO

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut:
• Invasive mucinous carcinoma GII
Biomarkers:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Strong nuclear reaction in 35% of tumor cells (Allred score 6/8)
Her-2: Negative membrane reaction (score 0)
Ki 67: 5% nuclear reaction

Prof. Gamal Abdel-Aty
Dr.Rana Fathy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor/Building No. 287- Nile Cornishe - Misr El Qadema- Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / صباح احمد احمد محمد	Request No.	: 135577
Patient No.	: 26212192100742	Request Date	: 21/09/2021
Path No.	: 2180	Verification Date	: 30/09/2021
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:		

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast mass

Nature of the speciment:
tru cut biopsy
Gross Examination:
• multiple fragmented gray white tissue cores up to 1x1 cm long, totally submitted

Microscopic examination:
• Histological type: IDC (mucinous carcinoma)
• Grade II
• Angioinvasion: NO
• Ductal carcinoma in situ: NO

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut:
• Invasive mucinous carcinoma GII
For (ER, PR, Her2, Ki67)

Prof. Gamal Abdel-Aty
Dr.Rana Fathy

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (957) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) First Floor Building No. 957 Nile Corniche Misr El Qadema Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]